SENTENÇA

Processo: 0800310-47.2025.8.19.0048

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: S. M. C., MICHELE DE PAULA RIBEIRO MATHEUS

RÉU: UNIMED MARQUES DE VALENCA COOP DE TRABALHO MEDICO

Trata-se de demanda ajuizada por SAMUEL MATHEUS CORREA, representado por MICHELE DE PAULA RIBEIRO MATHEUS, em desfavor de UNIMED MARQUÊS DE VALENÇA COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA, pretendendo a condenação do réu a fornecer-lhe o medicamento **Duvyzat (givinostat)** para o tratamento de sua patologia, CID10: G71.0, *Distrofia Muscular de Duchenne* (DMD), tendo em vista que teve seu requerimento administrativo negado pelo réu em razão de não possuir cobertura contratual, conforme *Comprovante de Negativa Contratual / Assistencial* de id. 207656196, bem como compensação por dano moral.

Petição inicial no id. 207656162, instruída.

Manifestação do Ministério Público (CPC, art. 178, II) no id. 208078361.

Manifestação do autor no id. 208485251.

Relatado, decido.

Defiro a gratuidade da justiça ao autor.

Da preliminar de incompetência.

O Ministério Público suscita a preliminar de incompetência deste Juízo, sob a alegação de que "*as demandas de medicamento sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, o que atrai[ria] a competência para a Justiça Federal*" com base no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 500 do STF refere-se à *possibilidade, ou não, do Estado ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA*. Em decorrência, fixou-se a *Tese 4*, segundo a qual "*As ações que exigem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União*", o que, de fato, atrairia a competência da Justiça Federal. Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que esta demanda não trata de direito requerido em desfavor de ente estatal, mas de pessoa jurídica de direito privado, não se aplicando essa Tese, portanto, ao caso em apreço por se tratar de relação de direito privado.

Dessarte, **rejeito** a preliminar suscitada.

Inexistem outras questões processuais pendentes, nem outras preliminares a serem analisadas. Estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições para o regular exercício do direito de ação, titularizando as partes o direito material em litígio. Passo, pois, à análise do mérito.

Inicialmente, diga-se que o direito à saúde é assegurado a todos, conforme expressamente previsto no art. 196 da Constituição Federal, e encontra-se indissociável do direito à vida.

É inegável que o §1º do art. 5º da Constituição Federal se aplica não somente aos direitos ali consagrados, como também a todos aqueles previstos em seu Título II, o que impõe o reconhecimento de que o direito social à saúde é fundamental, sendo imperioso que a Carta Política seja interpretada de forma a dar efetividade a tal direito.

Nessa linha de raciocínio, diante do direito social e fundamental à saúde, corolário do direito à vida e da dignidade humana, e dos interesses financeiros e secundários dos contratos, há, inevitavelmente, que prevalecer o primeiro.

O reconhecimento da prevalência de tal direito está fundamentado na função social do contrato, diante do fato de que toda a coletividade deve receber tratamento condigno, em conformidade com o estado atual da ciência médica, rechaçando, assim, qualquer argumento de violação da isonomia.

Há duas premissas a serem analisadas.

A primeira diz respeito à recusa do réu em fornecer o medicamento requerido pelo autor.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao plano de assistência à saúde recusar o fornecimento de medicamento para uso domiciliar (assistência farmacêutica), salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim, bem como aqueles previstos contratualmente.

> AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. **PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE**. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. **LIMITAÇÃO LÍCITA**. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE

MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. **É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, **salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim**. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 3. **Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde**. 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

O mesmo entendimento é acompanhado por este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. **PLANO DE SAÚDE. PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE**. CONSULTAS COM ESPECIALISTA. ÔNUS DA RÉ DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL APTO NA REDE CONVENIADA. ÓRTESE. PREVISÃO CONTRATUAL. **MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO**. HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO. EXCLUSÃO PELO ÓRGÃO REGULADOR. PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA E PRESTADA PELA RÉ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. **Ação proposta por criança portadora de distrofia muscular de Duchenne em face de operadora de saúde**. 2. Sentença de procedência parcial do pedido. 3. […] 6. **Medicamentos para uso domiciliar. Obrigatoriedade restrita aos antineoplásicos, medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para tal fim (REsp nº 1.692.938/SP).** 7. […] 10. Provimento parcial do segundo apelo (manejado pela ré), para excluir a condenação à indenização do dano material referente às consultas não reembolsadas, diante da inexistência de recibos comprobatórios do dispêndio nos autos, apesar de reconhecida a obrigação de fazer. (0006780-91.2020.8.19.0052 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 14/09/2023 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA)

A segunda premissa, e a mais importante, diz respeito ao fornecimento, na saúde suplementar, de medicamentos sem registro na ANVISA.

Essa questão encontra-se representada pelo Tema Repetitivo 990 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Questão submetida a julgamento. Definir se as operadoras de plano de saúde estão obrigadas ou não a fornecer medicamento importado, não registrado na ANVISA.

Tese Firmada. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

No caso em apreço, o medicamento requerido pelo autor – **Duvyzat** –, como informado por ele na petição inicial, "*ainda não possui aprovação da **ANVISA** no Brasil*" (fls. 2). Dessa forma, a causa em análise adequa-se a esse Tema, uma vez que se trata de pretensão dirigida a obrigar plano de saúde a fornecer medicamento não registrado na ANVISA, o que, por sua vez, atrai a previsão contida no inc. II do art. 332 do Código de Processo Civil, ou seja, é o caso de improcedência liminar do pedido, porque ele contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do recurso repetitivo no REsp 1712163 – SP, que originou o Tema Repetitivo 990, acima transcrito.

Em que pese a alegação do autor de que "*tais precedentes preveem exceções expressas*", "*[restando] preenchidos os requisitos fixados no Tema 500 do STF*", como já mencionado nesta decisão, o Tema 500 do STF aplica-se ao fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não se referindo ao sistema de saúde suplementar, como é o presente caso, sendo firme a jurisprudência nesse sentido.

> AGRAVO INTERNO. **PLANO DE SAÚDE. CONCEITO DE MEDICAMENTO NÃO NACIONALIZADO. FÁRMACO IMPORTADO, SEM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. TESE VINCULANTE, SUFRAGADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 990**. FÁRMACO SEM SUBMISSÃO AO SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILÂNCIA. IMPRÓPRIO PARA FORNECIMENTO NO MERCADO DE CONSUMO. 1. **Como admite a recorrente, o medicamento importado, vindicado na ação, não tem nem sequer registro na Anvisa, não sendo, pois, medicamento importado nacionalizado**. Isso porque, como é de sabença, inclusive reforçado pelo art. 20, § 1º, V, da Resolução ANS n. 428/2017 - Rol da ANS vigente por ocasião do ajuizamento da ação -, **são considerados medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na Anvisa**. E o art. 17, parágrafo único, V, da Resolução ANS n. 465/2021 (vigente Rol da ANS), também explicita o que seja medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, uma vez que esclarece que são aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA. 2. A Segunda Seção definiu que "**estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados** (art. 10, I e V, da Lei nº 9.656/1998). Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nºs [...] 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). Com efeito, é bem de ver que **o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998 expressamente exclui da relação contratual** a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, **fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes, sendo certo que, diversamente do uso off label de medicamento, não trata-se de imposição de custeio de fármaco devidamente registrado na Anvisa**, aprovado em ensaios clínicos, notadamente submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância - próprio

para fornecimento no mercado de consumo - e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica" (REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018). 3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, **a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos**. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente. (AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) 4. **"No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)"** (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 5. **Conforme tese sufragada em recurso repetitivo, "é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76**"(REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.530/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Não se trata de recusa a tratamento a doença prevista contratualmente ou com previsão legal, mas de assistência farmacêutica fora dos casos legais e contratuais.

Registre-se, por fim, que esta demanda trata de causa que dispensa a fase instrutória, uma vez que se refere estritamente à questão de direito.

Desse modo, deve-se rejeitar liminarmente o pedido principal formulado, e, por arrastamento, o de compensação por dano moral.

Diante do exposto, **JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS**, extinguindo o processo com o julgamento do mérito, nos termos dos art. 487, I, c/c art. 332, II, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade fica suspensa.

Deixo de condenar o autor, por ora, ao pagamento de honorários de advogado, tendo em vista a atual não triangulação da relação processual.

Com o trânsito em julgado e não interposta apelação, intime-se o réu (CPC, art. 332, § 2º, c/c art. 241). Após, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

RIO DAS FLORES, 15 de julho de 2025.

KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
Juíza Titular

Assinado eletronicamente por: KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD
15/07/2025 19:08:19
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25071519081950900000198279994

IMPRIMIR GERAR PDF